

Договор на оказание стоматологических услуг

Заключение по действующему бланку клиники · юридический отдел FutureFlow · ООО «АНГЕЛ-ДЕНТ» · 7 сентября 2026

Главное

Бланк, по которому клиника сегодня заключает договоры с пациентами, требованиям законодательства не соответствует. Требования к договору платных медуслуг менялись дважды — с 1 сентября 2023 года и с 1 сентября 2026 года, когда вступили в силу новые Правила (постановление Правительства РФ от 30.05.2026 № 659). Бланк не учитывает ни те, ни другие: по половине пунктов обязательного перечня он просто молчит.

Всего 26 находок: 5 ошибок, ломающих документ, 12 обязательных по закону сведений и условий, которых нет вовсе, 8 условий, ущемляющих права пациента, и техническая небрежность в реквизитах. Отдельно разобраны 13 ситуаций с пациентом, которые бланк не предусматривает: в каждой пациент оказывается прав, потому что договор на его стороне.

Латать этот текст смысла нет — мы написали новый договор целиком. Он приложен к заключению: 13 разделов, одно приложение — план лечения, отдельные согласия. Все 26 находок в нём закрыты. Клинике остаётся вписать пять своих значений — они перечислены в конце.

Отдельно — 16 механизмов защиты клиники, которых в прежнем бланке не было вовсе: неустойка за просрочку, право приостановить лечение, односторонний акт, аванс по фактическим расходам, правила неявок, продление сроков по вине пациента, исключения из гарантии, осмотр до переделки в другой клинике, порядок экспертизы и другие. Все они законны — то есть в суде устоят, а не будут отброшены как ущемляющие права потребителя.

Что обязательно указывать в договоре

Отдельный вопрос клиники: хватит ли одних Ф. И. О. и нельзя ли обойтись офертой. Ответ — по действующим Правилам, а не по обычаю.

1. Адрес и телефон пациента — обязательны

П. 23 «б» Правил: договор должен содержать фамилию, имя и отчество, адрес места жительства, иные адреса для ответов на письменные обращения и номер телефона потребителя. То же — по заказчику (пп. «г») и по законному представителю (пп. «в»). Это не обычай делового оборота, а прямой перечень: обойтись одними Ф. И. О. нельзя.

2. Паспортные данные — тоже обязательны

Тот же пункт требует «данные документа, удостоверяющего личность» — и у пациента, и у заказчика, и у законного представителя (плюс у представителя — документ, подтверждающий его полномочия). Единственное исключение — оказание услуг анонимно, но анонимно закон разрешает лишь отдельные виды помощи, и стоматология в их число не входит. В нынешнем бланке паспорт и адрес есть только у заказчика — у пациента их нет вовсе.

3. Собирать паспорт законно — это не «лишние данные»

Обработка таких данных не требует отдельного разрешения: она нужна для исполнения договора и прямо предписана нормативным актом (п. 2 ч. 1 ст. 6 закона № 152-ФЗ). Паспортные данные клиника всё равно вносит в медицинскую карту, так что новых сведений договор не добавляет — он лишь фиксирует то, что уже собрано.

4. Оферта — можно, но она не заменяет этих сведений

Раздел VI Правил (пп. 40–48) разрешает заключать договор дистанционным способом: через сайт клиники или мобильное приложение, акцептом — согласием или оплатой. До этого на главной странице сайта размещается информация об исполнителе, пациенту выдаётся подтверждение с номером договора, а по его требованию — экземпляр, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью. Идентификация возможна в том числе через Госуслуги (ЕСИА). Но перечень сведений п. 23 остаётся тем же: оферта меняет способ заключения договора, а не его состав.

5. Как это выглядит на практике

Оферта на сайте удобна для онлайн-записи и предоплаты. Лечение в кресле она не закрывает: перед вмешательством всё равно берутся информированное добровольное согласие и анамнез, а медицинскую карту без паспортных данных не завести. Поэтому рабочая схема — обычный бумажный договор с полным блоком данных, а оферта на сайте как дополнительный канал, а не замена договора ради экономии двух строк в бланке.

Что видно по самому бланку

Это не придирки к формулировкам: перечисленное ниже — признаки того, что документ много лет не пересматривал профильный юрист.

1. Бланк отстал от Правил на две редакции

Требования к договору платных медуслуг менялись дважды: с 1 сентября 2023 года (Правила № 736) и с 1 сентября 2026 года — сейчас действуют Правила, утверждённые постановлением Правительства РФ от 30.05.2026 № 659. Обязательный перечень сведений из п. 23 новых Правил в бланке не выполнен: нет данных пациента как потребителя и его подписи, нет срока предоставления услуг, адреса места оказания, перечня работ по лицензии, нет условий о смете. Документ живёт в логике правил, отменённых ещё в 2023 году.

2. В тексте нет ни одной ссылки на закон

На весь договор — только общая формулировка «в соответствии с законодательством РФ» и одно упоминание закона об основах охраны здоровья. Ни Гражданского кодекса, ни закона о защите прав потребителей, ни закона № 152-ФЗ. Юрист так договор не пишет: ссылка на норму — это то, чем условие защищается в суде.

3. Реквизиты не сверялись годами

Номер лицензии ЛО-50-01-007867 перевыпущен, действующий — ЛО41-01162-50/00299266. Корреспондентский счёт написан 21 цифрой вместо 20 — это видно без всякой юриспруденции, простым пересчётом. Один из расчётных счетов, которыми пользуется бланк, не сходится по контрольному ключу.

4. Правки вносились копипастом

Сбита нумерация: после 3.1.1 сразу 3.1.3, после 3.2.1 — 3.2.3. Два пункта слиты в одну строку. По рукам ходят копии бланка с разными реквизитами — номером лицензии, адресом, расчётным счётом. Администратор распечатает ту, что попадётся, и пациент получит договор со старой лицензией или со счётом, на который не пройдёт платёж.

5. Защита клиники сведена к трём фразам

В договоре нет ни неустойки, ни ответственности Заказчика за просрочку, ни порядка приостановки лечения при неоплате, ни правил приёма услуг — акт упомянут, но что делать, если пациент его не подписывает, не сказано. Односторонние формулировки «Исполнитель не несёт ответственность» суд не применит, а работающих механизмов не заложено.

6. Соглашения оформлены так, что не работают

Разрешение на фотографии и на SMS вшито условиями договора. Оговорка «не указывая персональных данных» ситуацию не спасает: изображение гражданина защищается ст. 152.1 ГК само по себе, а согласие на обнародование должно быть отдельным и отзывным. Информированного согласия на вмешательство и согласия на обработку данных о здоровье нет вовсе — это два документа, без которых проверка Росздравнадзора заканчивается предписанием.

Чем это грозит клинике

1. Спор с пациентом стоит дороже самой услуги

Сроки в договоре не определены — по ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» пациент вправе требовать неустойку 3 % за каждый день, вплоть до полной цены услуги. Сверху суд взыскивает штраф 50 % от присуждённого (п. 6 ст. 13) и компенсацию морального вреда (ст. 15). На имплантации за 150 000 ₽ это оборачивается суммой около двух её стоимостей — и это при качественно сделанной работе, просто из-за формулировок.

2. Ущемляющие условия ничтожны и наказуемы

Сто процентов предоплаты, «спор рассматривает руководитель клиники» и разрешение на фото условием договора — это ст. 16 Закона «О защите прав потребителей»: такие условия недействительны, убытки возмещаются, а за само их включение в договор предусмотрен административный штраф на юридическое лицо (ч. 2 ст. 14.8 КоАП). Для привлечения достаточно одной жалобы в Роспотребнадзор.

3. Проверка Росздравнадзора — по документам, а не по лечению

Отсутствие информированного добровольного согласия (ст. 20 закона № 323-ФЗ) и неполные обязательные сведения в договоре видны в первые полчаса проверки: это бумаги, их не нужно доказывать экспертизой.

4. Договор может быть признан заключённым не с клиникой

Подписант действует по трудовому договору, а не по доверенности. По ст. 183 ГК такая сделка считается заключённой лично с подписавшим. В споре это означает, что клиника лишается собственных условий договора — всех сразу.

Ошибки, которые ломают документ

1. Подписант действует по трудовому договору, а не по доверенности

В преамбуле: «в лице Коммерческого директора Наджарова А. А., действующего на основании Трудового договора № 2/23 от 01.12.2023». Трудовой договор полномочий выступать от имени общества не даёт: по ст. 53 ГК и ст. 40 закона об ООО без доверенности действует только генеральный директор. Формально по ст. 183 ГК такая сделка считается заключённой лично с подписантом — в споре с пациентом это первое, за что зацепится юрист.

Что сделать: Выдать доверенность и написать в преамбуле «действующего на основании доверенности № __ от __». Либо договор подписывает генеральный директор.

2. Корреспондентский счёт написан с лишней цифрой

В бланке стоит 301018104700000000225 — это 21 знак, а корреспондентский счёт всегда 20. Правильный корсчёт Сбербанк по БИК 044525225 — 30101810400000000225. По нынешним реквизитам платёж уходит в отбраковку.

Что сделать: Исправить корсчёт. Ошибка не юридическая, а арифметическая — её ловит обычная проверка реквизитов, и то, что она годами в бланке, говорит само за себя.

3. В обороте два разных расчётных счёта, и один из них нерабочий

В копиях бланка встречаются счета 40702810240020000960 и 40702810310001942141. Второй при БИК 044525225 не сходится по контрольному ключу — банк такой платёж не проведёт. Отдельно: в бланке указан Сбербанк, а счета клиника выставляет через ВТБ.

Что сделать: Оставить один действующий счёт и один банк, сверив их с бухгалтерией.

4. Номер лицензии в бланке недействующий

Указан ЛО-50-01-007867 — старый номер. Действующий, по которому клиника значится в реестре Росздравнадзора и который стоит на сайтах, — ЛО41-01162-50/00299266 от 19.07.2016.

Что сделать: Сведения о лицензии — обязательная часть договора (п. 23 «а» Правил). Неверный номер — это недостоверная информация для потребителя.

5. Адрес исполнителя расходится с ЕГРЮЛ

В части копий бланка адрес записан как «помещение 2», тогда как в ЕГРЮЛ — «помещение V». Мелочь, но это реквизит стороны договора: в претензии или иске им пользуются, чтобы поставить под сомнение сам документ.

Что сделать: Привести адрес к выписке: 143968, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 22, помещение V.

Чего не хватает по закону

Требования — Правила предоставления платных медицинских услуг (постановление Правительства РФ от 30.05.2026 № 659, действуют с 1 сентября 2026 года), закон № 323-ФЗ и закон № 152-ФЗ.

1. Пациент в договоре не идентифицирован

Правила (п. 23 «б») требуют в договоре ФИО, адрес места жительства, телефон и данные документа, удостоверяющего личность потребителя, — то есть самого пациента. В бланке эти поля есть только у Заказчика. При этом бланк подписи прямо рассчитан на законного представителя: значит, случай «заказчик ≠ пациент» штатный, а данных пациента нет.

Что сделать: Стороной договора сделан сам Пациент: блок с ФИО, датой рождения, паспортом, адресом и телефоном. Отдельного «Заказчика» нет — так проще и так делает большинство клиник; для ребёнка одна строка законного представителя.

2. Нет подписи пациента

Тот же пункт (подпункт «и»): договор подписывают исполнитель, потребитель и (или) заказчик. Сейчас подписывает только Заказчик. Отдельно не сказано, кто подписывает за ребёнка: до 15 лет это законный представитель (ст. 54 закона № 323-ФЗ).

Что сделать: Подписывает Пациент; за ребёнка до 15 лет или недееспособного — законный представитель, для которого предусмотрены строка данных и подпись.

3. Число экземпляров не привязано к числу сторон

П. 7.2: «Договор составлен в 2-х экземплярах» — притом что бланк рассчитан на заказчика и представителя, то есть сторон могло быть три. По п. 24 Правил количество экземпляров соответствует количеству сторон.

Что сделать: Сторон две — клиника и пациент, экземпляров два; если подписывает законный представитель, экземпляр пациента передаётся ему.

4. Не указано место оказания услуг

В договоре только юридический адрес клиники. Медицинская лицензия привязана к адресам мест деятельности, а юрлицо одно на три клиники: по такому договору выходит, что услуги в «Венеции» (Мытищи, ул. Мира, 37) оказываются в Реутове.

Что сделать: Адрес клиники подставлен в бланк — и в шапке, и в реквизитах: печатать и подписывать можно как есть.

5. Не определены сроки оказания услуг

Правила (п. 23 «ж») требуют указать срок предоставления услуг. В договоре их нет: п. 1.3 отсылает к плану лечения, а п. 7.1 говорит «до выполнения обязательств». Если срок не согласован, потребитель вправе назначить его сам и требовать неустойку 3 % за каждый день (ст. 27–28 ЗоЗПП).

Что сделать: Заведён отдельный раздел «Сроки оказания услуг» с правилом их продления по причинам, зависящим от Пациента.

6. Нет информированного добровольного согласия

Ст. 20 закона № 323-ФЗ: до любого медицинского вмешательства берётся ИДС — отдельный документ по форме Минздрава (приказ № 1051н). Приложений к договору всего два: анкета анамнеза и план лечения. Договор согласие не заменяет.

Что сделать: Это первое, что проверяет Росздравнадзор. Приложением к договору ИДС не делаем — это самостоятельный документ по форме Минздрава, он живёт в медицинской карте; договор на него ссылается (п. 4.2). Бланки нужны отдельные: общий на приём и на имплантацию, удаление, наркоз.

7. Персональные данные и врачебная тайна не урегулированы

Данные о здоровье — специальная категория (ст. 10 закона № 152-ФЗ). В договоре нет ни правового основания их обработки, ни согласия на передачу сведений лаборатории — а передача врачебной тайны третьим лицам требует письменного согласия (ч. 3 ст. 13 закона № 323-ФЗ). Лишнюю бумагу при этом плодить не нужно: для самого лечения согласие на обработку данных закон не требует.

Что сделать: П. 9.1 — обработка идёт для исполнения договора и в медицинских целях лицами, обязанными хранить врачебную тайну (п. 5 ч. 1 ст. 6 и п. 4 ч. 2 ст. 10 закона № 152-ФЗ), отдельное согласие не нужно. П. 9.1.1 — письменное согласие на передачу сведений лаборатории прямо в тексте договора. Реклама, SMS и фото — отдельными галочками, как и требует закон.

8. Не оговорено привлечение третьих лиц

Коронки и протезы делает зуботехническая лаборатория, снимки — сторонний центр. По ст. 780 ГК исполнитель обязан оказать услугу лично, если договором не предусмотрено иное. Такой оговорки нет.

Что сделать: Добавлен пункт о праве привлекать третьих лиц с сохранением ответственности клиники за их действия (ст. 403 ГК).

9. Не установлены гарантийные сроки

П. 6.5 отсылает к плану лечения, но сама форма плана гарантийных сроков не содержит. Если срок не установлен, требования по недостаткам можно предъявлять два года (п. 3 ст. 29 ЗоЗПП) — то есть по умолчанию действует худший для клиники вариант.

Что сделать: Заведён раздел «Гарантийные сроки» с условиями сохранения гарантии. Сами сроки клинике нужно проставить в форме плана лечения.

10. Сведения о лицензии неполные

П. 23 «а» Правил требует регистрационный номер лицензии, дату её предоставления, лицензирующий орган и перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, по единому реестру лицензий Росздравнадзора. В бланке только номер (устаревший) и дата.

Что сделать: Реквизитный блок дополнен: действующий номер, дата, Минздрав Московской области, отсылка к выписке из реестра лицензий и указание, что лицензия бессрочна.

11. В договоре ни слова о смете

П. 25 Правил: на оказание услуг может быть составлена твёрдая или приблизительная смета, и по требованию пациента, заказчика или самой клиники составление сметы обязательно — смета становится неотъемлемой частью договора. В бланке слова «смета» нет вовсе, а плану лечения этой роли не присвоено.

Что сделать: План лечения прямо назван сметой: по умолчанию твёрдая, изменение — только новым планом или дополнительным соглашением.

12. Перечень приложений не сходится с текстом

П. 2.3 ссылается на график платежей (Приложение № 3), а в разделе 10 «Неотъемлемые части» перечислены только приложения 1 и 2. Анкета анамнеза при этом названа приложением к договору, хотя это документ медицинской карты.

Что сделать: Приложение одно — план лечения (смета): только то, без чего договор по п. 23 и п. 25 Правил неполон. Анкета и информированное согласие — в медицинской карте, график платежей — дополнительное соглашение, когда даётся рассрочка.

Условия, ущемляющие права пациента

Такие условия недействительны по ст. 16 Закона «О защите прав потребителей»: в споре они не работают, а за их включение в договор предусмотрен административный штраф.

1. П. 6.7 — право публиковать фотографии

Разрешение размещать фото полости рта в каталогах, на сайте и в соцсетях вшито в договор условием. Согласие на обнародование изображения (ст. 152.1 ГК) должно быть отдельным и отзывным, а включение его в договор об услугах Роспотребнадзор трактует как навязывание (ст. 16 ЗоЗПП, штраф по ст. 14.8 КоАП).

Что сделать: Вынесено в блок «Отдельные согласия» с выбором «согласен / не согласен» и оговоркой, что отказ не влияет на оказание услуг.

2. П. 6.6 — согласие на SMS

То же самое. Сервисные напоминания о приёме допустимы, но рекламная рассылка требует отдельного согласия (ст. 18 закона «О рекламе»).

Что сделать: Разведено на две галочки: сервисные сообщения и рекламные рассылки.

3. П. 2.4 — стопроцентная предоплата

За ортопедию, ортодонтию и имплантацию берётся 100 % аванс за всю услугу. Безусловная полная предоплата ущемляет право потребителя отказаться от договора в любой момент (ст. 32 ЗоЗПП, ст. 782 ГК).

Что сделать: Аванс привязан к тому, что клиника реально закупает под пациента, — стоимости изделий и работ лаборатории, с потолком в процентах от этапа.

4. П. 5.1 — спор рассматривает руководитель клиники

Читается как обязательный досудебный порядок, навязанный пациенту.

Что сделать: Прямо написано, что обращение к клинике не обязательно и не мешает пойти в суд, Роспотребнадзор или Росздравнадзор, а иск подаётся по выбору истца.

5. П. 4.2 – «Исполнитель не несёт ответственность»

Список случаев безусловного освобождения от ответственности потребителю противопоставить нельзя: вина оценивается судом, а не назначается договором.

Что сделать: Переписано: перечисленные обстоятельства «учитываются при оценке качества услуги и вины Исполнителя» и фиксируются в медицинской документации.

6. П. 3.2.1 – замена врача без согласия пациента

Клиника вправе назначить другого врача просто «в случае отсутствия» прежнего. Право пациента выбрать врача закреплено ст. 21 закона № 323-ФЗ и ч. 1 ст. 70 – замена без согласия его нарушает.

Что сделать: Добавлено «с согласия Пациента» и прямая ссылка на сохранение права выбора.

7. П. 3.3.7 – обязанность ходить на осмотры каждые полгода

Как обязанность по договору это навязывание услуги: клиника не может обязать человека приходить. Как условие сохранения гарантии – законно.

Что сделать: Перенесено из обязанностей в раздел «Гарантийные сроки» как правило пользования результатом услуги.

8. П. 4.2.2 – снятие ответственности за ранее леченные зубы

«Осложнения при лечении зубов, ранее леченных в другом учреждении» – слишком широко: взявшись за зуб, клиника отвечает за результат.

Что сделать: Работает только если риск был объяснён пациенту и это зафиксировано под подпись – так и записано в новой редакции.

Ситуации с пациентом, которых бланк не учитывает

Претензии, которые чаще всего предъявляют стоматологиям, и то, чем пациент обоснует каждую по нынешнему тексту договора.

1. «Вы подняли цену между визитами»

На что сошлётся: П. 2.1 и 3.3.9 говорят «по прейскуранту на момент оказания», а п. 2.2 – «цена плана не меняется». Противоречие внутри одного договора толкуется в пользу потребителя (ст. 431 ГК, п. 4 ст. 12 ЗоЗПП).

В новой редакции: Цена фиксируется планом лечения; меняется только новым планом или допсоглашением.

2. «Вы не назвали срок – я жду четвёртый месяц»

На что сошлётся: Срок оказания в договоре не определён. По ст. 28 ЗоЗПП потребитель вправе назначить новый срок и требовать неустойку 3 % за каждый день просрочки.

В новой редакции: Сроки этапов и общий срок – в плане лечения; продление только по документально зафиксированным причинам.

3. «Мне поменяли врача, я шёл к конкретному»

На что сошлётся: Ст. 21 закона № 323-ФЗ – право на выбор врача; договор его игнорирует.

В новой редакции: Замена врача – только с согласия Пациента.

4. «Я не подписал акт, значит платить не обязан»

На что сошлётся: П. 2.3: основанием для оплаты является подписанный акт. Пациент просто не подписывает – и формально основания для оплаты нет.

В новой редакции: Введён односторонний акт: нет мотивированных возражений за 5 рабочих дней – услуги считаются принятыми.

5. «Верните всю предоплату»

На что сошлётся: Ст. 32 ЗоЗПП: отказаться можно в любой момент, вернув только фактические расходы. Стопроцентный аванс за услугу, к которой не приступали, придётся вернуть целиком.

В новой редакции: Аванс равен стоимости изделий и работ лаборатории — то есть тому, что клиника действительно потратила.

6. «Моё фото у вас в соцсетях»

На что сошлётся: Ст. 152.1 ГК: обнародование изображения — только с согласия, и согласие отзывно. Условие в договоре Роспотребнадзор считает навязанным.

В новой редакции: Отдельная галочка с правом отозвать согласие.

7. «Коронка треснула через год — где гарантия?»

На что сошлётся: Гарантийные сроки нигде не установлены, значит работает общий двухлетний срок (п. 3 ст. 29 ЗоЗПП) и все сомнения против клиники.

В новой редакции: Раздел «Гарантийные сроки» плюс графа гарантии в форме плана лечения.

8. «Договор подписал не директор»

На что сошлётся: Полномочия по трудовому договору — не полномочия действовать от имени общества. По ст. 183 ГК сделка считается заключённой с подписантом лично.

В новой редакции: Основание полномочий — Устав или доверенность с номером и датой.

9. «Мне не дали справку для налогового вычета»

На что сошлётся: Справку об оплате медицинских услуг клиника обязана выдать; отказ — прямой повод для жалобы, а для пациента это потерянные 13 % от чека.

В новой редакции: Пункт о бесплатной выдаче справки в течение 10 рабочих дней.

10. «Коронку делали не вы, а лаборатория»

На что сошлётся: Ст. 780 ГК: исполнитель обязан оказать услугу лично, если договором не предусмотрено иное. Оговорки не было.

В новой редакции: Право привлекать третьих лиц прописано, ответственность остаётся на клинике.

11. «Вы обязали меня ходить к вам каждые полгода»

На что сошлётся: Обязанность посещать клинику — навязанная услуга (ст. 16 ЗоЗПП).

В новой редакции: Перенесено в условия сохранения гарантии.

12. «В договоре Реутов, а лечили меня в Мытищах»

На что сошлётся: Место оказания услуг не указано, а лицензия привязана к адресам. Пациент может поставить под сомнение законность оказания услуги.

В новой редакции: Адрес клиники отмечается в самом договоре.

13. «За ребёнка подписала мама — а её данных в договоре нет»

На что сошлётся: П. 23 «в» Правил: по законному представителю нужны ФИО, адрес, телефон, паспорт и документ, подтверждающий полномочия. В бланке представитель лишь упомянут в заголовке подписи.

В новой редакции: Отдельная строка законного представителя с паспортом и документом о полномочиях (свидетельство о рождении, акт опеки).

Ещё одно замечание

Регистрирующий орган назван МИФНС № 20 — это та, что выдавала свидетельство в 2013 году. Сейчас клинику ведёт МИФНС № 23. Для ссылки на старое свидетельство это правильно, менять не нужно — просто чтобы не смущало при сверке.

Что в бланке сделано правильно

Заключение было бы нечестным без этого раздела: часть требований в документе учтена.

- Информация о праве получить помощь бесплатно по программе госгарантий (п. 6.4) — обязательна по ч. 6 ст. 84 закона № 323-ФЗ, и она есть.
- Предупреждение, что несоблюдение рекомендаций врача снижает качество услуги (п. 6.2) — тоже требование Правил, есть.
- Выдача медицинских документов по заявлению в течение 10 дней без доплаты (п. 3.1.4.1) — обязательное условие договора по п. 23 «м» Правил, есть.
- Оговорка, что осложнения, которые нельзя полностью исключить, не считаются недостатком качества (п. 6.3) — сформулировано корректно и защищает клинику.
- Право пациента отказаться от лечения с расчётом по фактически оказанному (п. 3.4.2) — соответствует ст. 782 ГК.

Чего в бланке не было для защиты клиники

Прежний договор защищал клинику тремя фразами, и все три — неработающие. Ниже механизмы, которых в нём не было вовсе: каждый законен, то есть устоит в суде, а не будет отброшен как ущемляющий права потребителя.

1. Просрочка оплаты ничем не грозила пациенту

Чем это грозило: Ни неустойки, ни процентов, ни права остановить лечение. Долг можно было тянуть месяцами, а клиника продолжала работать и тратить на изделия.

В новом договоре: П. 2.8 — неустойка 0,1 % за день просрочки, но не более суммы долга. П. 4.9 — право приостановить лечение; приостановка не считается отказом от договора, и срок лечения на этот период продлевается.

2. Пациент мог просто не подписать акт

Чем это грозило: Акт упомянут как основание оплаты, но что делать при отказе его подписать — не сказано. Формально услуга не принята, значит и требовать оплату не с чего.

В новом договоре: П. 2.6 — односторонний акт: нет мотивированных возражений за 5 рабочих дней — услуги считаются принятыми. Право заявить о недостатках позже сохраняется, так что условие законно.

3. Аванс был оформлен так, что его пришлось бы вернуть целиком

Чем это грозило: Стопроцентная предоплата за услугу ущемляет право отказаться от договора (ст. 32 ЗоЗПП): суд обяжет вернуть всё, даже если коронка уже заказана в лаборатории.

В новом договоре: П. 2.5 — аванс равен стоимости изделий и работ третьих лиц, то есть тому, что клиника реально потратила. Такие расходы по закону не возвращаются, и деньги остаются у клиники обоснованно.

4. Неявки и опоздания ничем не регулировались

Чем это грозило: Пустое кресло — прямой убыток, но в договоре об этом ни слова.

В новом договоре: П. 3.4 — при опоздании более 15 минут приём сокращается или переносится; после двух неявок без предупреждения время резервируется под предоплату, которая засчитывается в счёт лечения (это не штраф, поэтому условие устоит).

5. Срыв сроков по вине пациента считался бы срывом по вине клиники

Чем это грозило: Сроков в договоре не было вовсе, а по ст. 28 ЗоЗПП просрочка тянет неустойку 3 % в день. Пациент не приходил месяц — виновата всё равно клиника.

В новом договоре: П. 3.2 — сроки продлеваются на период, когда лечение не могло идти по причинам, зависящим от пациента (неявка, невыполнение назначений, отказ от обследований), и причина фиксируется в медицинской документации.

6. Отказ пациента от части лечения нигде не фиксировался

Чем это грозило: Классика спора: пациент отказался от лечения канала или от защитной капы, через год скол коронки — и виновата клиника, потому что доказательств отказа нет.

В новом договоре: П. 5.9 — отказ от рекомендованного объёма фиксируется письменно с разъяснением последствий. П. 6.5 — на такой результат гарантия не распространяется.

7. Гарантия работала против клиники

Чем это грозило: Сроков не установлено — значит два года по п. 3 ст. 29 ЗоЗПП, и любые сомнения толкуются в пользу пациента. Исключений из гарантии не было ни одного.

В новом договоре: Раздел 6: гарантийный срок и срок службы разведены (истечение срока службы — не недостаток), перечислены случаи, на которые гарантия не распространяется — временные конструкции, травма, бруксизм без капы, вмешательство третьих лиц, возрастные изменения, естественный износ.

8. Пациент мог переделать работу в другой клинике и прислать счёт

Чем это грозило: Право требовать возмещения расходов на устранение недостатков есть у него по закону. Если результат уже переделан, клиника не может ни осмотреть его, ни доказать, что недостатка не было.

В новом договоре: П. 8.5 — до устранения недостатков силами третьих лиц пациент даёт клинике осмотреть результат, осмотр оформляется актом.

9. Экспертиза качества не была урегулирована

Чем это грозило: Кто её проводит и за чей счёт — молчание, а в споре это ключевой вопрос.

В новом договоре: П. 8.6 — экспертиза за счёт клиники, пациент вправе присутствовать; если экспертиза покажет, что недостаток возник не по вине клиники, расходы возмещает пациент.

10. Вместо оценки вины стоял запрещённый список «мы не отвечаем»

Чем это грозило: Перечень безусловных освобождений от ответственности потребителю не противопоставить: он ничтожен, и в суде клиника остаётся вообще без аргументов.

В новом договоре: П. 7.3 — те же обстоятельства (невыполнение назначений, недостоверные сведения о здоровье, неявка, отказ от обследований) названы тем, чем они являются: фактами, которые учитываются при оценке качества услуги и вины, и фиксируются в медицинской документации. Это работает, а запрет — нет.

11. Работа лаборатории была нарушением договора

Чем это грозило: По ст. 780 ГК исполнитель обязан оказать услугу лично, если иное не предусмотрено. Оговорки не было — значит каждая коронка формально сделана с нарушением.

В новом договоре: П. 1.6 — право привлекать зуботехническую лабораторию и диагностический центр прямо закреплено; ответственность перед пациентом остаётся на клинике (ст. 403 ГК), как и требует закон.

12. Уведомления пациенту ничего не значили

Чем это грозило: Пациент не берёт трубку и не получает письмо — и клиника не может доказать, что предупреждала о переносе, о долге или о готовности работы.

В новом договоре: Раздел 11 — сообщение считается доставленным и тогда, когда не вручено по обстоятельствам, зависящим от адресата (ст. 165.1 ГК); телефон, мессенджеры и электронная почта из реквизитов признаны юридически значимыми каналами. П. 5.8 — пациент обязан сообщать о смене контактов.

13. Фотопротокол и снимки висели в воздухе

Чем это грозило: Фотографии и рентген — главное доказательство клиники в споре, но их статус в договоре не был определён вовсе.

В новом договоре: П. 4.10 — фотопротокол и рентгенологические исследования названы частью медицинской документации и хранятся у клиники; для рекламы нужно отдельное согласие, и это разделение снимает претензии о «фото без спроса».

14. Претензия «мне никто ничего не объяснил» ничем не закрывалась

Чем это грозило: Обязанность информировать лежит на клинике, и доказывать её исполнение тоже ей.

В новом договоре: П. 13.5 — подписывая договор, пациент подтверждает, что получил сведения о клинике и лицензии, прейскурант, информацию о враче и его квалификации, о диагнозе, методах, рисках и вариантах лечения, о праве лечиться бесплатно по ОМС и ответы на все вопросы. Плюс информированное согласие отдельным документом по форме Минздрава.

15. Индивидуальные изделия при разрыве договора оставались ничьими

Чем это грозило: Коронка уже отлита под конкретного пациента — что с ней делать при отказе, договор не отвечал.

В новом договоре: П. 10.4 — изготовленные индивидуально изделия передаются пациенту при условии оплаты их стоимости.

16. Договор можно было оспорить целиком из-за одного условия

Чем это грозило: Если суд признал бы одно условие ущемляющим, судьба остальных оставалась открытой; в бланке не было ни оговорки о делимости, ни подтверждения выдачи экземпляров.

В новом договоре: П. 13.4 — недействительность отдельного условия не влечёт недействительности остальных. Под подписью — отметка, что экземпляр получен и с условиями, прейскурантом и информацией по п. 13.5 пациент ознакомлен до подписания; в колонтитуле каждой страницы название договора и «страница X из Y».

Как мы собрали новый договор

— Разобрали действующий бланк построчно и сверили каждый его пункт с обязательными требованиями действующих Правил (ПП РФ № 659, в силе с 1 сентября 2026 года) — от перечня сведений в п. 23 до числа экземпляров в п. 24 и сметы в п. 25.

— Сверили реквизиты: юридический адрес, ОГРН, КПП и наименование — с выпиской из ЕГРЮЛ, номер лицензии — с реестром Росздравнадзора, контрольные ключи банковских счетов пересчитали по алгоритму Банка России.

— Прошли по типовым спорам стоматологий: 13 претензий, которые пациент предъявляет чаще всего, — под каждую подобрали норму, на которую он сошлётся, и условие договора, которое её закрывает.

— Написали новый договор целиком, а не залатали старый: 13 разделов вместо прежних 10, одно приложение вместо россыпи бумаг, отдельные согласия вместо условий, вшитых в текст.

— Собрали его под реальный порядок приёма: подписывается на первом визите, когда плана лечения ещё нет, и действует на весь период лечения — администратору не нужно заводить новый договор на каждое посещение.

- Свели заполнение к минимуму: реквизиты клиники и банка, лицензия, подписант, аванс, сроки и адрес уже проставлены – администратору остаётся вписать номер, дату и данные пациента.
- Оставили на усмотрение клиники только то, что она должна решить сама: гарантийные сроки по видам работ и банк, через который принимает оплату.

Из чего он состоит

1. 13 разделов

Предмет · Цена и порядок оплаты · Сроки оказания · Обязанности и права Исполнителя · Обязанности и права Заказчика и Пациента · Гарантийные сроки · Ответственность Сторон · Недостатки услуг, претензии и споры · Персональные данные и врачебная тайна · Изменение и расторжение · Юридически значимые сообщения · Непреодолимая сила · Заключительные положения.

2. Договор подписывается на первичном приёме

Плана лечения в этот момент ещё нет – он появляется после осмотра и диагностики. Поэтому договор рамочный (ст. 429.1 ГК): при подписании он покрывает консультацию, осмотр, диагностику и помощь при острой боли по преискуранту, а дальнейшее лечение согласуется планом, который с момента подписания становится приложением. Договор заключается один раз и действует весь период лечения – при следующих визитах переподписывать его не нужно.

3. 1 приложение – план лечения (смета)

Перечень услуг, стоимость, последовательность и сроки этапов, гарантийные сроки и сроки службы – то, что п. 23 и п. 25 Правил требуют иметь в договоре. Больше приложений не нужно: анкета анамнеза и информированное согласие – документы медицинской карты, а не договора; согласие на обработку данных для лечения закон не требует; график платежей оформляется дополнительным соглашением только при рассрочке. Меньше бумаг на подпись – меньше ошибок при заполнении.

4. 3 отдельных согласия

На использование обезличенных фотографий, на сервисные сообщения о приёме и на рекламные рассылки – каждое с выбором «согласен / не согласен», отзывное, и отказ не влияет на оказание услуг.

5. Реквизитный блок и подписи

Две стороны – клиника и пациент, две подписи; для ребёнка до 15 лет одна строка законного представителя с паспортом и документом о полномочиях; реквизиты клиники, банк, лицензия и адрес места оказания услуг проставлены заранее.

Один текст на три клиники

Юридическое лицо у «Ангел-Дента», «Версаля» и «Венеции» одно – ООО «АНГЕЛ-ДЕНТ», ИНН 5012077543. Стороной договора выступает именно оно, а не клиника: клиника – это место оказания услуг, а не субъект права. Лицензия тоже одна – ЛО41-01162-50/00299266 от 19.07.2016; разными бывают не лицензии, а адреса мест осуществления деятельности внутри одной лицензии.

Правила требуют указать в договоре номер лицензии, дату, орган выдачи и адрес места оказания услуг. Поэтому текст договора для трёх клиник один, а печатный бланк собирается под конкретную клинику: адрес, телефон и почта подставлены сразу, отмечать ничего не нужно. Готов бланк «Ангел-Дента»; для «Версаля» и «Венеции» меняются только эти три строки, а юрлицо, лицензия и все условия остаются теми же.

Одно условие: адрес каждой клиники должен быть внесён в лицензию. Мытищи, ул. Мира, 37 – проверить по реестру Росздравнадзора; если адреса там нет, лицензию нужно переоформить, и это уже не вопрос формулировок в договоре.

Что требует закон, как было и как стало

Что требует закон	Как было	Как стало
Данные пациента: ФИО, адрес места жительства, телефон, паспорт (п. 23 «б»)	Есть только у Заказчика	Пациент – сторона договора, полный блок данных
Подписи исполнителя, потребителя и (или) заказчика (п. 23 «и»)	Подписывает только Заказчик	Подписывает Пациент; за ребёнка – представитель
Экземпляров – по числу сторон (п. 24)	Два, без привязки к сторонам	Два – по числу сторон
Адрес места оказания услуг (п. 23 «а»)	Только юрадрес в Реутове	Адрес клиники подставлен в бланк
Сведения о лицензии: номер, дата, орган, перечень работ (п. 23 «а»)	Устаревший номер, перечня работ нет	Действующий номер, орган, отсылка к реестру
Смета – по требованию любой стороны (п. 25 Правил)	Не упомянута	План лечения = смета, твёрдая по умолчанию
Срок предоставления услуг (п. 23 «ж»)	«До выполнения обязательств»	Сроки этапов в плане лечения + порядок продления
Информированное добровольное согласие (ст. 20 закона № 323-ФЗ)	Нет	Готовый бланк по приказу № 1051н, ссылка в п. 4.2
Согласие на обработку данных о здоровье (ст. 9–10 закона № 152-ФЗ)	Нет	Основание в п. 9.1, согласие на передачу лаборатории в п. 9.1.1
Согласие на публикацию фото (ст. 152.1 ГК)	Вшито условием договора	Отдельная отзывная галочка
Гарантийные сроки (ст. 29 ЗоЗПП)	Не установлены – работает 2 года	Раздел о гарантии + графа в плане лечения
Предоплата (ст. 32 ЗоЗПП, ст. 782 ГК)	100 % за ортопедию и имплантацию	По фактическим расходам на изделия
Привлечение лаборатории (ст. 780 ГК)	Не оговорено	Право есть, ответственность на клинике
Порядок приёма услуг	Акт упомянут, порядка нет	Односторонний акт: 5 рабочих дней на возражения
Досудебный порядок (ст. 17 ЗоЗПП)	«Спор рассматривает руководитель»	Обращение необязательно, иск по выбору истца

Синим – как это место сформулировано в новом договоре.

Что остаётся за клиникой

Бланк готов к печати: реквизиты, лицензия, адрес клиники, подписант, аванс (50 % цены этапа) и срок приостановки при неоплате (10 дней) уже проставлены. Осталось четыре вещи:

- номер и дату договора и данные пациента – их заполняет администратор при заключении;
- гарантийные сроки и сроки службы по видам работ – их место в форме плана лечения (Приложение № 1);
- сверить банковские реквизиты с бухгалтерией: в бланке стоит Сбербанк, а счета клиника выставляет через ВТБ (корреспондентский счёт мы уже исправили – в прежнем он был написан 21 цифрой);
- если договор подписывает не генеральный директор, заменить в преамбуле и в подписи ссылку на Устав доверенностью с номером и датой.

Что выдаётся пациенту вместе с договором. К заключению приложены ещё два бланка:

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (часть 1 – по форме приказа

Минздрава № 1051н, часть 2 — стоматологические вмешательства с уже напечатанными рисками, врач только отмечает нужное) и медицинская карта стоматологического пациента формы № 043/у с анкетой о здоровье. Без ИДС любое вмешательство — нарушение ст. 20 закона № 323-ФЗ, а карта по 043/у обязательна для стоматологии с 1 сентября 2025 года.

На что опирается заключение

- Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг — постановление Правительства РФ от 30.05.2026 № 659 (действуют с 01.09.2026 до 01.09.2031; заменили Правила № 736 от 11.05.2023).
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» — ст. 11 (экстренная помощь), 20 (информированное согласие), 21 (выбор врача), 54 (несовершеннолетние), 84 (платные услуги).
- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» — ст. 13, 15, 16, 17, 28, 29, 32.
- Гражданский кодекс РФ — ст. 152.1 (изображение гражданина), 183 (полномочия), 403 и 780 (привлечение третьих лиц), 426 (публичный договор), 782 (отказ от договора).
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» — ст. 6, 9, 10.
- Приказ Минздрава России от 12.11.2021 № 1051н — форма информированного добровольного согласия.
- Налоговый кодекс РФ, пп. 3 п. 1 ст. 219 — социальный налоговый вычет на лечение.
- Выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-26-154952194 от 13.08.2026 и единый реестр лицензий Росздравнадзора — сверка реквизитов и лицензии.

Заключение подготовлено юридическим отделом FutureFlow по тексту действующего бланка клиники. Реквизиты сверены с выпиской из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-26-154952194 от 13.08.2026, номер лицензии — с реестром Росздравнадзора, контрольные ключи счетов пересчитаны по алгоритму Банка России. Это анализ документа, а не представительство интересов: перед тем как пускать бланк в работу, финальную редакцию имеет смысл показать юристу, который ведёт клинику.